CD5+ : un phénotype, plusieurs diagnostics.

Approche multiparamétrique du diagnostic différentiel des hémopathies lymphoprolifératives B

R. LASGAA', N. ABBASEN', S. BOUNAAS', S. KEHILA', N. BOULEMKAHEL', I. LAROUS'
' Service d'Hémobiologie et Centre de Transfusion Sanguine, CHU Sétif, Algérie

INTRODUCTION

Le CD5 est exprimé par les lymphocytes T et par une sous-population de lymphocytes B. Son expression aberrante par une population B constitue un marqueur fréquent mais non spécifique. Elle est principalement observée dans :

- la leucémie lymphoide chronique/lymphome lymphocytique (LLC/LL)
- le lymphome à cellules du manteau (LCM)
- peut également étre retrouvée dans d'autres lymphoprolifération B.

Une interprétation isolée de ce marqueur peut conduire à des erreurs diagnostiques.

OBJECTIFS

- Souligner l'importance d'une approche multiparamétrique en cytométrie en flux.
- Proposer une démarche diagnostique structurée pour distinguer les principales hémopathies B CD5+.
- Mettre en évidence les marqueurs clés permettant d'orienter le diagnostic.

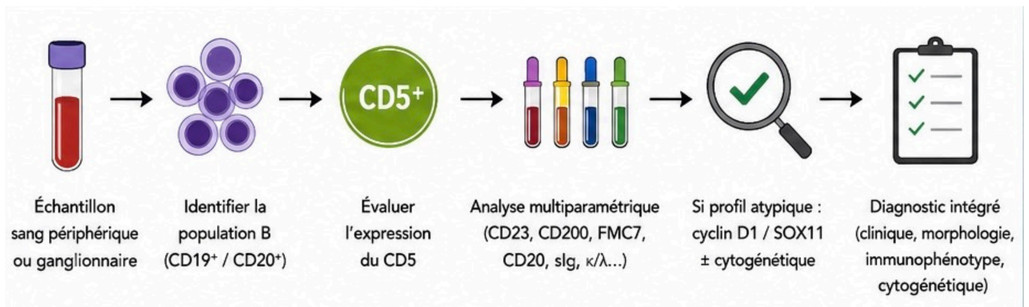
MATÉRIELS & MÉTHODES

Revue narrative de la littérature basée sur les classifications OMS 2022 et ICC 2022, portant sur l'immunophénotypage des hémopathies B CD5+.

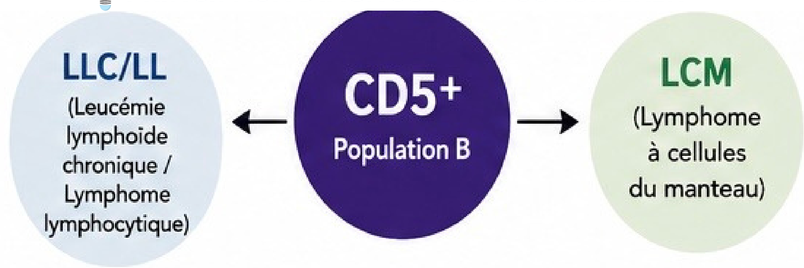
Les principaux marqueurs analysés incluent :

CD19, CD20, CD5, CD23, CD200, FMC7, immunoglobulines de surface, et, si nécessaire, la recherche de la cycline D1 et de SOX11, ainsi que des données cytogénétiques (t(11;14)).

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE EN CYTOMÉTRIE EN FLUX



PRINCIPAUX DIAGNOSTICS À CONSIDÉRER



Autres entités plus rares :

prolymphocytaires B, LLC atypiques, lymphomes diffus à grandes cellules B CD5+, lymphome splénique de la zone marginale, etc.

PROFILS IMMUNOPHÉNOTYPIQUES COMPARÉS

Marqueurs	LLC/LL typique	LCM typique	LLC atypique	LCM atypique
CD19	+	+	+	+
CD20	Faible	Fort	Variable (faible à modérée)	Variable (modérée à fort)
CD5	+	+	+	+
CD23	+	–	– / Faible	+ (rare)
CD200	+	– ou faible	– / Faible	– / Faible
FMC7	Faible / –	+	+ / –	+ / –
Ig de surface	Faible	Forte	Faible à modérée	Forte à modérée
Cycline D1	–	+	–	+ / – (rare)
SOX11	–	Souvent +	–	Souvent +
t(11;14) / CCND1	–	+	–	+ (rare)

+ : exprimé ; – : absent ; Faible / Fort : niveau d'expression relatif.
Les profils atypiques existent ; aucun marqueur isolé ne suffit à établir le diagnostic.

MARQUEURS CLÉS ET LEUR APPORT

CD23
Marqueur positif dans la majorité des LLC/LL.
Généralement négatif dans le LCM.

CD200
Positif dans la LLC/LL ; négatif ou faible dans le LCM.

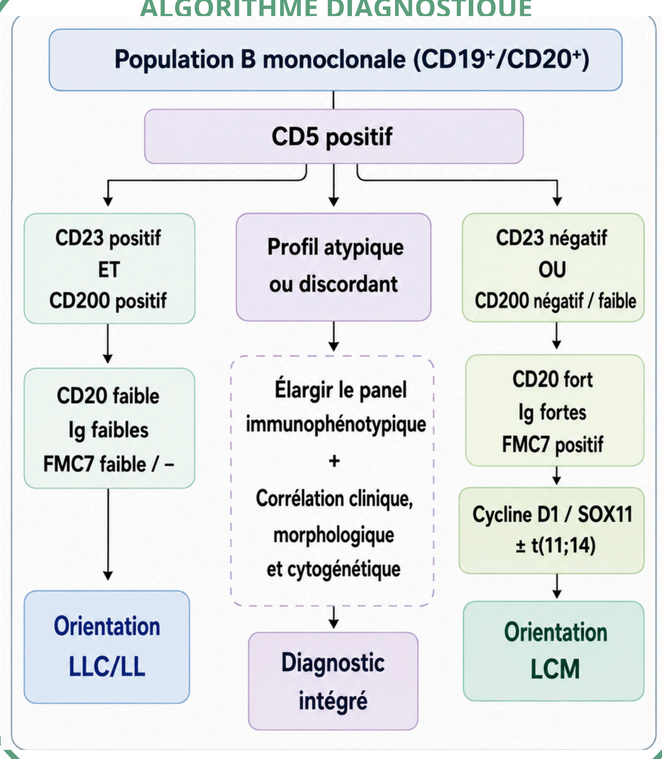
FMC7
Faible ou absent dans la LL/LL ; positif dans le LCM.

CD20 & Ig de surface
Faibles dans la LLC/LL ; fortement exprimés dans le LCM.

Cycline D1
Expression nucléaire caractéristique du LCM (associée à la t(11;14)).

SOX11
Souvent exprimé dans le LCM ; rarement dans la LLC/LL.

ALGORITHME DIAGNOSTIQUE



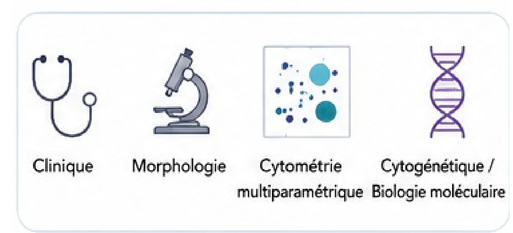
PIÈGES DIAGNOSTIQUES

- **CD5+ = LLC : FAUX**
 Le CD5 n'est pas spécifique d'une entité.
- **CD23+ = LLC : PAS TOUJOURS**
 Certains LCM peuvent exprimer le CD23.
- **CD23- = LCM : PAS OBLIGATOIREMENT**
 Certaines LLC présentent un profil atypique.
- **CD200- = LCM : NON SUFFISANT**
 Doit être interprété avec le reste du profil.
- **Négliger l'intensité d'expression des marqueurs.**
- **Oublier l'intégration clinico-biologique.**

Interpréter un PROFIL et non un MARQUEUR isolé.

MESSAGE CLÉ

> **CD5+ n'est pas un diagnostic, mais un point de départ du raisonnement.**



La combinaison des marqueurs constitue la signature diagnostique.

CONCLUSION

L'expression du CDS par une population lymphoide 8 doit toujours tre interprétéo dans un contexte multiparamétrique. L'intégration des marqueurs CD23, CO200.9. FMC7, CO20, des immunoglobuines de surface, ainsi que, si nécessaire, de la cycline Di et de SOX11, permet de distinguer la LLC/LL du LCM et des autres entitès B CDS•. Cette approche intégrée rebuit tes errours dnanastiques et améliore la prise en charge des patients.

RÉFÉRENCES

- WHO Classification of Tumours of Haematopcietic and Lymphoid Tissues, Sth edition, 2022.
- International Consensus Classification (CC) of Mature Lymphoid Neoplesms, 2022.
- Romatron AC. Flow cytometry in the dagnosis of chronic lymphocytic leukerris. Blood. 2013
- Wang L, et al. Flow cytomatric differential diagnosis of COS* B-cell lymphoproferative disorders. Front Oncol. 2022.
- Xu-Monette ZY, et al. SOXI1 is a useful marker for mantle cell lymphoma. Mod Pathol. 2012.